

โครงการประชุมเช้าย่อย (Morning Talk)

หน่วยซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ | ฝ่ายวิศวกรรมการแพทย์
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ	โครงการประชุมเช้าย่อย (Morning Talk)	ปีงบประมาณ	2568–2569
หน่วยงาน	ฝ่ายวิศวกรรมการแพทย์ รพ.นครพิงค์	ระยะเวลา	ต.ค. 2568 – ก.ย. 2569
เวลา	08:30 – 08:40 น. (≤ 10 นาที)	วันดำเนินการ	จันทร์ – ศุกร์ (วันราชการ)

1. หลักการและเหตุผล

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ปฏิบัติงานเฉพาะเวลาราชการ ขณะที่โรงพยาบาลให้บริการ 24 ชั่วโมง เมื่อเครื่องมือชำรุดนอกเวลา ใช้ระบบ ศูนย์ยืม-คืน เครื่องมือแพทย์ทดแทน ปัญหาที่พบ ได้แก่ ข้อมูลงานค้างไม่ถูกส่งต่ออย่างเป็นระบบ LINE กลุ่มไม่รับประกันการรับรู้ และขาดเวทีฝึกภาวะผู้นำ โครงการนี้จึงเป็น Stand-up Meeting ก่อนเริ่มงาน ไม่เกิน 10 นาที เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

- สื่อสารงานค้างจากเวรป่วย/ติคสู่ทีมเข้าอย่างครบถ้วน
- วางแผน PM, CAL, งานซ่อม D1–D3 ประจำวัน
- ฝึกภาวะผู้นำผ่านการหมุนเวียนนำประชุม
- ทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดหน่วยงาน
- ลดข้อผิดพลาดจากการสื่อสารไม่ครบถ้วน

3. รูปแบบและขั้นตอน Morning Talk (≤ 10 นาที)



เวลา	กิจกรรม
นาทีที่ 1	เปิดประชุม – ผู้นำวันนี้แนะนำตัวและประกาศจำนวนงานรวม
นาทีที่ 2–3	รายงานงานค้าง – จากเวรป่วย เวรติค ศูนย์ยืม และ LINE กลุ่ม
	แผนงานวันนี้ – PM, Calibration (CAL), งานซ่อม D1/D2/D3, และงานนอกแผน
นาทีที่ 7–8	ปัญหาและข้อเสนอแนะ – ปัญหาที่ต้องการให้หัวหน้าติดตาม หรือต้องการสนับสนุน
	ทบทวนเป้าหมายหน่วยงาน – ตัวชี้วัดประจำเดือน/ไตรมาส
นาทีที่ 10	มอบหมายงานและปิดประชุม – ผู้นำสรุปและส่งมอบงาน

4. เงื่อนไขการเข้าร่วมตามตารางเวรศุูนย์ยืม



Phase 1: Morning Talk เฉพาะวันที่ไม่มีช่วงขึ้นเวรตึกศุูนย์ยืม เพื่อลดแรงกดดันผู้ปฏิบัติงาน

5. เป้าหมายและตัวชี้วัด (KPI)

ตัวชี้วัด	รายละเอียด	เกณฑ์
ความสม่ำเสมอในการจัด	Morning Talk	≥ 80% ของวันทำการ
การหมุนเวียนผู้นำ	ทุกคนได้นำอย่างน้อย	1 ครั้ง/เดือน
งานค้างเวร	ถูกส่งต่ออย่างครบถ้วน	100%
ความพึงพอใจทีม	แบบประเมินรายไตรมาส	≥ 3.5/5.0
ระยะเวลาประชุม	ไม่เกิน 10 นาที	≥ 90% ของครั้งที่จัด

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ข้อมูลงานค้างจากเวรตึก/ป่วยถูกส่งต่ออย่างครบถ้วนและทันเวลา ลดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยผู้ป่วย
บุคลากรทุกคนได้รับโอกาสฝึกภาวะผู้นำและทักษะการสื่อสารในที่สาธารณะ
ทีมมีความเข้าใจเป้าหมายของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
ลดปัญหาการสื่อสารผ่าน LINE ที่ไม่ได้รับการยืนยัน
สร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก (Proactive) ในทีมซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์
ลดเวลาซ่อมโดยรวม (TAT) เนื่องจากมีการวางแผนงานที่ดีขึ้น